



**LABCENTER**  
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.

Matriz: Rua Conselheiro Pedreira, 624, Pirabeiraba - Joinville/SC

CNPJ: 81.614.380/0001-56

CNES: 2521490 | CRF/SC 3981

Responsável Técnico: Flavio Ricardo Barbosa (CRF/SC 3547)

(47) 3427-3668

www.laboratoriolabcenter.com.br



Paciente.... **ALLISON HAUT MONTALVAO**

Dr(a)..... **MICHELE CRISTINA MENDONCA SENHORINI**

Data da Entrada..... **15/04/2026**

Idade: 25A 0M 17D Data Nasc.: 29/03/2001 Pedido... **370053764**

Convênio..... **UNIMED GIMENES INTERCAMBIO (CIDADES FOR**

CPF do paciente: 104.083.609-76

## HEMOGRAMA COMPLETO

Data de Coleta..... 15/04/2026 07:58

Material biológico: ST/EDTA

### SÉRIE VERMELHA

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Hemácias.....    | <b>5,02</b> milhões/mm <sup>3</sup> |
| Hemoglobina..... | <b>14,1</b> g/dL                    |
| Hematócrito..... | <b>43,8</b> %                       |
| V.C.M.....       | <b>87,3</b> fL                      |
| H.C.M.....       | <b>28,1</b> pg                      |
| C.H.C.M.....     | <b>32,2</b> g/dL                    |
| R.D.W.....       | <b>12,4</b> %                       |

Método: Citometria de Fluxo Fluorescente e Impedância

### Valores Referenciais

4,50 a 5,50

13,0 a 17,0

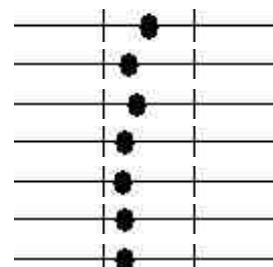
40,0 a 50,0

83,0 a 101,0

27,0 a 32,0

31,5 a 34,5

11,6 a 14,8



### SÉRIE BRANCA

|                          | %           | /mm <sup>3</sup> |
|--------------------------|-------------|------------------|
| Leucócitos.....          |             | <b>5.070</b>     |
| Blastos.....             | <b>0,0</b>  | <b>0</b>         |
| Pró-mielócitos.....      | <b>0,0</b>  | <b>0</b>         |
| Mielócitos.....          | <b>0,0</b>  | <b>0</b>         |
| Metamielócitos.....      | <b>0,0</b>  | <b>0</b>         |
| Bastonetes.....          | <b>0,0</b>  | <b>0</b>         |
| Segmentados.....         | <b>42,4</b> | <b>2.150</b>     |
| Eosinófilos.....         | <b>6,1</b>  | <b>309</b>       |
| Basófilos.....           | <b>0,6</b>  | <b>30</b>        |
| Linfócitos.....          | <b>44,0</b> | <b>2.231</b>     |
| Linfócitos Reativos..... | <b>0,0</b>  | <b>0</b>         |
| Monócitos.....           | <b>6,9</b>  | <b>350</b>       |

% /mm<sup>3</sup>

4.000 a 10.000

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0 a 5,0

0 a 500

45,0 a 70,0

1.800 a 7.000

1,0 a 7,0

40 a 700

0,0 a 3,0

0 a 300

20,0 a 50,0

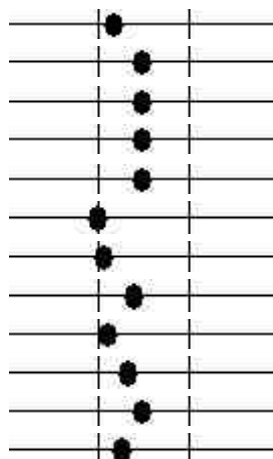
800 a 5.000

0,0

0

2,0 a 10,0

80 a 1.000



**PLAQUETAS..... 162.000 mm<sup>3</sup>**

**VPM..... 12,90 fL**

150.000 a 400.000

7,00 a 10,50

**Nota:** Exame automatizado por citometria de fluxo fluorescente e impedância, com confirmação das contagens e análise morfológica do esfregaço sanguíneo por microscopia, quando aplicável.

**Data e hora de liberação: 15/04/2026 15:51**

CNES Executante: 2521474

**Liberado por: MARCOS ANTONIO TOZETTO CRF - 2778**





Matriz: Rua Conselheiro Pedreira, 624, Pirabeiraba - Joinville/SC  
CNPJ: 81.614.380/0001-56  
CNES: 2521490 | CRF/SC 3981  
Responsável Técnico: Flavio Ricardo Barbosa (CRF/SC 3547)

(47) 3427-3668

www.laboratoriolabcenter.com.br



Paciente.... **ALLISON HAUT MONTALVAO** Idade: 25A 0M 17D Data Nasc.: 29/03/2001 Pedido... **370053764**  
Dr(a)..... **MICHELE CRISTINA MENDONCA SENHORINI** Convênio..... **UNIMED GIMENES INTERCAMBIO (CIDADES FOR**  
Data da Entrada..... **15/04/2026** CPF do paciente: 104.083.609-76

## COLESTEROL TOTAL

Data de Coleta..... 15/04/2026 07:58

Material biológico: Soro

Método: Colorimétrico enzimático - Cobas c 503/Roche

VALOR DE REFERÊNCIA:

**Resultado..... 173,00 mg/dL**

Desejável (COM OU SEM JEJUM): inferior a 190,00 mg/dL

\* Atualização dos valores de referência a partir de 06/11/2025, segundo Ditretiz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção de Arteriosclerose - 2025.

**Nota:** Valores de Colesterol Total maior ou igual a 310,00 mg/dL (para adultos) ou colesterol Total maior ou igual a 230,00 mg/dL (entre 2 e 19 anos) podem ser indicativos de Hipercolesterolemia Familiar (European Heart Journal, doi 10.1093/eurheartj/eh273).

Data e hora de liberação: 15/04/2026 17:16

Liberado por: JULIANA RECZKOWSKI DE FREITAS - CRBM 010245

CNES Executante: 2521474

## COLESTEROL HDL

Data de Coleta..... 15/04/2026 07:58

Material biológico: Soro

Método: Colorimétrico enzimático - Cobas c 503/Roche

VALOR DE REFERÊNCIA:

**Resultado..... 47,60 mg/dL**

Desejável (COM OU SEM JEJUM): Superior a 40,00 mg/dL

\* Atualização dos valores de referência a partir de 06/11/2025, segundo Ditretiz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção de Arteriosclerose - 2025.

Data e hora de liberação: 15/04/2026 17:15

Liberado por: JULIANA RECZKOWSKI DE FREITAS - CRBM 010245

CNES Executante: 2521474

## COLESTEROL LDL

Data de Coleta..... 15/04/2026 07:58

Material biológico: Soro

Método: Cálculo - Fórmula de Martin

VALOR DE REFERÊNCIA:

**Resultado..... 105,78 mg/dL**

Valores de ALVO TERAPÊUTICO (COM OU SEM JEJUM) sugerido para Categoria de Risco Cardiovascular estimado pelo médico assistente:

- CATEGORIA DE RISCO BAIXO: inferior a 115,00 mg/dL
- CATEGORIA DE RISCO INTERMEDIÁRIO: inferior a 100,00 mg/dL
- CATEGORIA DE RISCO ALTO: inferior a 70,00 mg/dL
- CATEGORIA DE RISCO MUITO ALTO: inferior a 50,00 mg/dL
- CATEGORIA DE RISCO EXTREMO: inferior a 40,00 mg/dL

\* Atualização dos valores de referência a partir de 06/11/2025, segundo Ditretiz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção de Arteriosclerose - 2025.

**Nota:** - Os valores de referência do Colesterol NÃO-HDL foram substituídos pelos valores de alvo terapêutico, estimados pelo médico de acordo com a categoria de risco cardiovascular. Desta forma, é necessário PRIMEIRO classificar o paciente quanto a seu RISCO CARDÍACO, para DEPOIS verificar o valor do NÃO-HDL desejável.

- A interpretação clínica dos resultados deverá levar em consideração o motivo da indicação do exame, o estado metabólico do paciente e estratificação do risco para estabelecimento das metas terapêuticas.

Data e hora de liberação: 15/04/2026 17:15

Liberado por: JULIANA RECZKOWSKI DE FREITAS - CRBM 010245

CNES Executante: 2521474





Matriz: Rua Conselheiro Pedreira, 624, Pirabeiraba - Joinville/SC  
CNPJ: 81.614.380/0001-56  
CNES: 2521490 | CRF/SC 3981  
Responsável Técnico: Flavio Ricardo Barbosa (CRF/SC 3547)

(47) 3427-3668

www.laboratoriolabcenter.com.br



Paciente.... **ALLISON HAUT MONTALVAO** Idade: 25A 0M 17D Data Nasc.: 29/03/2001 Pedido... **370053764**  
Dr(a)..... **MICHELE CRISTINA MENDONCA SENHORINI** Convênio..... **UNIMED GIMENES INTERCAMBIO (CIDADES FOR**  
Data da Entrada..... **15/04/2026** CPF do paciente: 104.083.609-76

## COLESTEROL NÃO HDL

Data de Coleta..... 15/04/2026 07:58

Material biológico: Soro

Método: Colorimétrico enzimático - Cobas c 503/Roche

**Resultado..... 125,40 mg/dL**

### VALOR DE REFERÊNCIA:

Valores de ALVO TERAPÊUTICO (COM OU SEM JEJUM) sugerido para Categoria de Risco Cardiovascular estimado pelo médico assistente:

- CATEGORIA DE RISCO BAIXO: inferior a 145,00 mg/dL
- CATEGORIA DE RISCO INTERMEDIÁRIO: inferior a 130,00 mg/dL
- CATEGORIA DE RISCO ALTO: inferior a 100,00 mg/dL
- CATEGORIA DE RISCO MUITO ALTO: inferior a 80,00 mg/dL
- CATEGORIA DE RISCO EXTREMO: inferior a 70,00 mg/dL

\* Atualização dos valores de referência a partir de 06/11/2025, segundo Ditretiz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção de Arteriosclerose - 2025.

**Nota:** - Os valores de referência do Colesterol NÃO-HDL foram substituídos pelos valores de alvo terapêutico, estimados pelo médico de acordo com a categoria de risco cardiovascular. Desta forma, é necessário PRIMEIRO classificar o paciente quanto a seu RISCO CARDÍACO, para DEPOIS verificar o valor do NÃO-HDL desejável.  
- A interpretação clínica dos resultados deverá levar em consideração o motivo da indicação do exame, o estado metabólico do paciente e estratificação do risco para estabelecimento das metas terapêuticas.

Data e hora de liberação: 15/04/2026 17:15

Liberado por: JULIANA RECZKOWSKI DE FREITAS - CRBM 010245

CNES Executante: 2521474

## CREATININA

Data de Coleta..... 15/04/2026 07:57

Material biológico: Soro

Método: Enzimático - Cobas c 503/Roche

**Resultado..... 1,06 mg/dL**

### VALOR DE REFERÊNCIA:

Masculino: 0,70 a 1,20 mg/dL



## ESTIMATIVA DA TAXA DE FILTRAÇÃO GLOMERULAR (eTFG)

### MÉTODO: CÁLCULO PELA FÓRMULA CKD-EPI (2021)

**eTFG..... 99,88 mL/min. x 1,73 m²**

VALOR DE REFERÊNCIA: Adultos maiores de 18 anos: superior a 90 mL/min/1,73 m²

**Nota:** - Após os 40 anos de idade, espera-se uma redução de cerca de 1 mL/min do Ritmo de Filtração Glomerular (RFG) por ano.  
- A estimativa do RFG não deve ser utilizada em indivíduos hospitalizados com concentrações de creatinina instáveis, principalmente pacientes com Insuficiência Renal Aguda.  
- O uso da estimativa de RFG também não é recomendado em indivíduos com dietas vegetarianas ou que fazem uso de suplementos de creatina, em extremos de massa muscular (amputados, paraplégicos, desnutridos, fisiculturistas), e em gestantes.  
- Fonte da Fórmula CKD-EPI 2021: Miller WG et al. National Kidney Foundation Laboratory Engagement Working Group Recommendations for Implementing the CKD-EPI 2021 Race-Free Equations for Estimated Glomerular Filtration Rate: Practical Guidance for Clinical Laboratories. Clin Chem. 2022;68(4):511-520.  
- O uso recente de dipirona podem ocasionar discreta redução nos níveis de creatinina dosada pelo método Enzimático.

Data e hora de liberação: 15/04/2026 17:15

Liberado por: JULIANA RECZKOWSKI DE FREITAS - CRBM 010245

CNES Executante: 2521474





**LABCENTER**  
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.

Matriz: Rua Conselheiro Pedreira, 624, Pirabeiraba - Joinville/SC

CNPJ: 81.614.380/0001-56

CNES: 2521490 | CRF/SC 3981

Responsável Técnico: Flavio Ricardo Barbosa (CRF/SC 3547)

(47) 3427-3668

www.laboratoriolabcenter.com.br



Paciente.... **ALLISON HAUT MONTALVAO**

Dr(a)..... **MICHELE CRISTINA MENDONCA SENHORINI**

Data da Entrada..... **15/04/2026**

Idade: 25A 0M 17D Data Nasc.: 29/03/2001 Pedido... **370053764**

Convênio..... **UNIMED GIMENES INTERCAMBIO (CIDADES FOR**

CPF do paciente: 104.083.609-76

## GLICOSE (JEJUM)

Data de Coleta..... 15/04/2026 07:57

Material biológico: Plasma/FLUORETO

Método: Enzimático - Cobas c 503/Roche

VALOR DE REFERÊNCIA:

Resultado.....

**90,00** mg/dL

60,00 a 99,00 mg/dL



**Nota:** Ref: The Expert Committee on The Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus. Follow-up Report on the Diagnosis of Diabetes Mellitus. Diabetes Care 2003;26(11):3160-3167.

Data e hora de liberação: **15/04/2026 15:52**

Liberado por: **JULIANA RECZKOWSKI DE FREITAS - CRBM 010245**

CNES Executante: 2521474

## HEMOGLOBINA GLICADA (A1C)

Data da Coleta..... 15/04/2026 07:57

Material biológico: ST/EDTA

Método: Imunoturbidimétrico - Cobas c 503/Roche

VALOR DE REFERÊNCIA:

Resultado A1C.....

**5,54** %



4,80 a 5,90%

Glicose Estimada Média.....

**112,30** mg/dL

**Nota: Meta terapêutica:**

- . Pacientes DM1 ou DM2 menor que 7,00%
- . Idoso Saudável menor que 7,50%
- . Idoso Comprometido menor que 8,50%
- . Criança e Adolescente menor que 7,00%

Referência: Diretriz Oficial da Sociedade Brasileira de Diabetes (2022)

Data e hora de liberação: **15/04/2026 16:51**

Liberado por: **JULIANA RECZKOWSKI DE FREITAS - CRBM 010245**

CNES Executante: 2521474





**LABCENTER**  
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.

Matriz: Rua Conselheiro Pedreira, 624, Pirabeiraba - Joinville/SC

CNPJ: 81.614.380/0001-56

CNES: 2521490 | CRF/SC 3981

Responsável Técnico: Flavio Ricardo Barbosa (CRF/SC 3547)

(47) 3427-3668

www.laboratoriolabcenter.com.br



Paciente.... **ALLISON HAUT MONTALVAO**

Dr(a)..... **MICHELE CRISTINA MENDONCA SENHORINI**

Data da Entrada..... **15/04/2026**

Idade: 25A 0M 17D Data Nasc.: 29/03/2001 Pedido... **370053764**

Convênio..... **UNIMED GIMENES INTERCAMBIO (CIDADES FOR**

CPF do paciente: 104.083.609-76

## **HEPATITE B, HBSAG (ANTÍGENO AUSTRÁLIA)**

Data de Coleta..... 15/04/2026 07:56

Material biológico: Soro

Método: Eletroquimioluminescência (ECLIA) - Elecsys/Roche

**Resultado (COI).....**

**0,26**

**Interpretação.....**

**Não Reagente**

**VALOR DE REFERÊNCIA:**

Não reagente: COI < 0,90

Zona Cinza (Indeterminado): COI >= 0,90 a < 1,00

Reagente: COI >= 1,00

**Nota:** - A sensibilidade e especificidade dos exames laboratoriais não correspondem a 100% e, portanto, é possível a ocorrência de resultados falso-positivos, falso-negativos ou mesmo discrepantes entre os diferentes testes realizados.

- A interpretação de um resultado laboratorial requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo(a) médico(a).

- Em caso de dúvida, a critério clínico sugere-se repetição do teste em nova amostra para observação da evolução do quadro sorológico.

- De acordo com o Manual técnico para o diagnóstico das hepatites virais, para a confirmação de infecção ativa pelo HBV, é necessário realizar a pesquisa de anti-HBc Total e/ou a quantificação da carga viral. Para indivíduos menores de 18 meses, devido a possível presença de anticorpos maternos, é indicada apenas a quantificação da carga viral para a confirmação. Ministério da Saúde, 2018.

- A vacina contra a hepatite A faz parte do calendário de vacinação do SUS para crianças de 12 a 23 meses. Além disso, ela está disponível nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), sendo indicada para as situações previstas em: <http://www.aids.gov.br/pagina/vacina-hepatites>.

- A vacina contra a hepatite B faz parte do calendário de vacinação da criança e está disponível nas salas de vacina do Sistema Único de Saúde (SUS) para as situações previstas em: <http://www.aids.gov.br/pagina/vacina-hepatites>.

- Testes com leituras próximas ao valor de corte podem representar resultado falso negativo ou positivo devido à variabilidade analítica do ensaio e possíveis interferentes. A critério médico, sugere-se repetição do exame em outro método para confirmação.

**Data e hora de liberação: 15/04/2026 17:22**

**Liberado por: JULIANA RECZKOWSKI DE FREITAS - CRBM 010245**

CNES Executante: 2521474





**LABCENTER**  
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.

Matriz: Rua Conselheiro Pedreira, 624, Pirabeiraba - Joinville/SC

CNPJ: 81.614.380/0001-56

CNES: 2521490 | CRF/SC 3981

Responsável Técnico: Flavio Ricardo Barbosa (CRF/SC 3547)

(47) 3427-3668

www.laboratoriolabcenter.com.br



Paciente.... **ALLISON HAUT MONTALVAO**

Dr(a)..... **MICHELE CRISTINA MENDONCA SENHORINI**

Data da Entrada..... **15/04/2026**

Idade: 25A 0M 17D Data Nasc.: 29/03/2001 Pedido... **370053764**

Convênio..... **UNIMED GIMENES INTERCAMBIO (CIDADES FOR**

CPF do paciente: 104.083.609-76

## HEPATITE C, ANTI HCV

Data de Coleta..... 15/04/2026 07:56

Material biológico: Soro

Método: Eletroquimioluminescência (ECLIA) - Elecsys/Roche

**Resultado (COI).....**

**0,05**

**Interpretação.....**

**Não Reagente**

VALOR DE REFERÊNCIA:

Não reagente: COI < 0,90

Zona Cinza (Indeterminado): COI >= 0,90 a < 1,00

Reagente: COI >= 1,00

**Nota:** - O resultado não reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus do HCV. Deve-se considerar o período da "Janela Imunológica". Em caso de suspeita de infecção pelo HCV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra para a realização de um novo teste.

- Somente será considerado resultado definitivamente reagente quando a amostra reagente para HCV em teste de triagem for reagente por um teste confirmatório (PCR).

- A sensibilidade e especificidade dos exames laboratoriais não correspondem a 100% e, portanto, é possível a ocorrência de resultados falso-positivos, falso-negativos ou mesmo discrepantes entre os diferentes testes realizados para esta análise.

- A interpretação do resultado laboratorial requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo(a) médico(a).

- De acordo com o Manual técnico para o diagnóstico das hepatites virais, para a confirmação de infecção ativa pelo HCV, é necessário realizar a quantificação da carga viral. Indivíduos menores de 18 meses podem possuir anticorpos maternos e, por isso, é indicada a detecção direta do vírus para o diagnóstico. Ministério da Saúde, 2015.

- A vacina contra a hepatite A faz parte do calendário de vacinação do SUS para crianças de 12 a 23 meses. Além disso, ela está disponível nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), sendo indicada para as situações previstas em: <http://www.aids.gov.br/pagina/vacina-hepatites>.

- A vacina contra a hepatite B faz parte do calendário de vacinação da criança e está disponível nas salas de vacina do Sistema Único de Saúde (SUS) para as situações previstas em: <http://www.aids.gov.br/pagina/vacina-hepatites>.

- Testes com leituras próximas ao valor de corte podem representar resultado falso negativo ou positivo devido à variabilidade analítica do ensaio e possíveis interferentes. A critério médico, sugere-se repetição do exame em outro método para confirmação.

- **Devido à alta sensibilidade do exame, resultados falso-positivos podem ocorrer, particularmente em índices baixos (< 5,00).**

Data e hora de liberação: 15/04/2026 17:22

Liberado por: JULIANA RECZKOWSKI DE FREITAS - CRBM 010245

CNES Executante: 2521474







**LABCENTER**  
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.

Matriz: Rua Conselheiro Pedreira, 624, Pirabeiraba - Joinville/SC

CNPJ: 81.614.380/0001-56

CNES: 2521490 | CRF/SC 3981

Responsável Técnico: Flavio Ricardo Barbosa (CRF/SC 3547)

(47) 3427-3668

www.laboratoriolabcenter.com.br



Paciente.... **ALLISON HAUT MONTALVAO** Idade: 25A 0M 17D Data Nasc.: 29/03/2001 Pedido... **370053764**  
Dr(a)..... **MICHELE CRISTINA MENDONCA SENHORINI** Convênio..... **UNIMED GIMENES INTERCAMBIO (CIDADES FOR**  
Data da Entrada..... **15/04/2026** CPF do paciente: 104.083.609-76

## **HIV 1 e 2 (PESQUISA DE ANTÍGENO/ANTICORPOS)-TESTE DE TRIAGEM**

Data de Coleta..... 15/04/2026 07:57

Material biológico: Soro

Método: Eletroquimioluminescência 4ª Geração(ECLIA) - Elecsys/Roche

VALOR DE REFERÊNCIA:

Resultado (COI).....

**0,25**

Não reagente: COI < 1,00

Interpretação.....

**Não Reagente**

Reagente: COI >= 1,00

### **Pesquisa simultânea de antígenos p24 do HIV e anticorpos anti-HIV-1 (grupo M e O) e anti-HIV-2.**

**Nota:** O diagnóstico sorológico da infecção pelo vírus HIV 1 e 2 deve ser realizado com pelo menos dois testes, um para triagem e um segundo, mais específico, para confirmar o resultado da triagem.

Desta forma, a critério médico, os resultados Reagentes deverão ser confirmados com testes complementares (Western Blot ou Imuno Blot e Teste Molecular-PCR), seguindo o fluxo estabelecido pela Portaria nº 29, de 17 de dezembro de 2013.

### **AMOSTRA NÃO REAGENTE PARA HIV**

O resultado não reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus HIV. Há de se considerar o período da 'Janela Imunológica'. Persistindo a suspeita de infecção pelo HIV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da amostra atual.

### **AMOSTRA REAGENTE PARA HIV:**

Somente será considerado definitivamente reagente quando a amostra reagente para HIV em teste de triagem for reagente por um teste confirmatório como Western Blot, Imuno Blot ou Teste Molecular (PCR). Resultado obtido utilizando o fluxograma, conforme estabelecido pela Portaria nº 29, de 17 de dezembro de 2013.

### **Observações:**

- 1 - A sensibilidade e especificidade dos exames laboratoriais para detecção da infecção pelo HIV não correspondem a 100% e, portanto, é possível a ocorrência de resultados falso-positivos, falso-negativos ou mesmo discrepantes entre os diferentes testes realizados para esta análise.
- 2 - Resultados falso-positivos em testes de triagem (por imunoensaio) para HIV podem ocorrer em pacientes com doenças autoimunes, hepatopatias, dialisados e em terapia com interferon, após vacinação recente contra influenza A-H1N1, múltiplas transfusões de sangue e gravidez.
- 3 - Resultados falso-negativos em testes de triagem (por imunoensaio) para HIV podem ocorrer na infecção aguda pelo HIV, em indivíduos imunossilenciosos, indivíduos com sistema imunológico comprometido e quando o teste for realizado anteriormente à soroconversão.
- 4 - A passagem transplacentária de anticorpos maternos do tipo IgG anti-HIV, principalmente no terceiro trimestre de gestação, interfere no diagnóstico sorológico da infecção vertical. Os anticorpos maternos podem persistir até os 18 meses de idade. Portanto, métodos que realizam a detecção de anticorpos não são recomendados para o diagnóstico em crianças menores de 18 meses de idade, sendo necessária a realização de testes moleculares, como a quantificação do RNA viral).\*
- 5 - A interpretação de qualquer resultado laboratorial para pesquisa de infecção pelo HIV requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo(a) médico(a).

\* Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais.

Data e hora de liberação: 15/04/2026 17:22

Liberado por: JULIANA RECZKOWSKI DE FREITAS - CRBM 010245

CNES Executante: 2521474





Matriz: Rua Conselheiro Pedreira, 624, Pirabeiraba - Joinville/SC  
CNPJ: 81.614.380/0001-56  
CNES: 2521490 | CRF/SC 3981  
Responsável Técnico: Flavio Ricardo Barbosa (CRF/SC 3547)

(47) 3427-3668

www.laboratoriolabcenter.com.br



|                      |                                            |                   |                                                |           |                  |
|----------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|-----------|------------------|
| Paciente....         | <b>ALLISON HAUT MONTALVAO</b>              | Idade: 25A 0M 17D | Data Nasc.: 29/03/2001                         | Pedido... | <b>370053764</b> |
| Dr(a).....           | <b>MICHELE CRISTINA MENDONCA SENHORINI</b> | Convênio.....     | <b>UNIMED GIMENES INTERCAMBIO (CIDADES FOR</b> |           |                  |
| Data da Entrada..... | <b>15/04/2026</b>                          | CPF do paciente:  | <b>104.083.609-76</b>                          |           |                  |

## VDRL

Data de Coleta..... 15/04/2026 07:57

Material biológico: Soro

Método: Flocculação (Teste não treponêmico)

VALOR DE REFERÊNCIA:

Não reagente

**Resultado Qualitativo..... Não Reagente**

**Resultado Quantitativo..... Não Reagente**

Conforme disposto na RDC nº786/ANVISA, de 05/05/2023 e atendendo a Portaria nº2.012, de 19/10/2016 e o respectivo Manual Técnico para o Diagnóstico da Sífilis, do Ministério da Saúde.

### Interpretação:

- Não reagente: Amostra não reagente para anticorpos não treponêmicos. Persistindo a suspeita clínica de Sífilis, deve-se repetir o teste após 30 dias com a coleta de nova amostra.
- Reagente: Amostra reagente para anticorpos não treponêmicos. Amostras VDRL reagentes devem ser testadas por métodos treponêmicos (Quimiluminescência, ELISA, FTA-Abs, Cromatografia, Hemaglutinação) para serem definidas como realmente reagentes para Sífilis, à critério médico.

### Observações:

- As amostras são testadas em diluição (1:1) e na diluição 1:8, conforme recomendações do Ministério da Saúde.
- Persistindo a dúvida diagnóstica nova amostra deverá ser coletada em 30 dias.
- Importante associar o resultado da testagem a informações clínico-epidemiológicas, para avaliar ocorrência de sífilis ativa ou cicatriz sorológica.
- A interpretação dos exames laboratoriais para a pesquisa de Sífilis requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizado apenas pelo(a) médico(a).
- A sensibilidade e especificidade dos exames laboratoriais para o diagnóstico da Sífilis não correspondem a 100% e, portanto, é possível a ocorrência de resultados falso-positivos, falso-negativos ou mesmo discrepantes entre os diferentes testes realizados para esta análise.

Data e hora de liberação: 15/04/2026 16:51

Liberado por: JULIANA RECZKOWSKI DE FREITAS - CRBM 010245

CNES Executante: 2521474

